

Validación de la versión española del International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form. Un cuestionario para evaluar la incontinencia urinaria



Montserrat Espuña Pons^a, Pablo Rebollo Álvarez^b y Montserrat Puig Clota^a

^aInstituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Hospital Clínic de Barcelona. Universitat de Barcelona. Barcelona.

^bUnidad de Investigación de Resultados en Salud. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

FUNDAMENTO Y OBJETIVO: Se estima que entre el 40 y el 70% de los sujetos con incontinencia urinaria (IU) no buscan atención médica. Los cuestionarios autoadministrados pueden ayudar a detectar la IU. El objetivo del estudio fue realizar la validación de la versión española del International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF).

PACIENTES Y MÉTODO: Contestaron el cuestionario 500 mujeres que acudieron consecutivamente a una unidad especializada en IU. A todas se les realizó un estudio urodinámico y se recogieron sus datos sociodemográficos y clínicos, a fin de disponer de diagnóstico tanto clínico como urodinámico. Se evaluaron la factibilidad, validez, fiabilidad y el poder diagnóstico respecto de ambos diagnósticos, y se calcularon la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivo y negativo.

RESULTADOS: El tiempo medio (desviación estándar) de administración del cuestionario fue de 3,5 (1,5) min. Ninguna paciente dejó algún ítem sin contestar. De acuerdo con el diagnóstico clínico, las pacientes con IU puntuaron 11,6 (5,9) y las pacientes sin IU, 4,5 (6,3) ($p < 0,001$). De acuerdo con el diagnóstico urodinámico, puntuaron 11,1 (6,3) frente a 6,2 (6,5) ($p < 0,001$). En las pacientes con diagnóstico urodinámico de IU de esfuerzo, la mayor gravedad se asoció a mayor puntuación del ICIQ: gravedad baja, 10,47 (5,61), frente a intermedia, 12,4 (5,72), frente a alta, 13,61 (5,42). El alfa de Cronbach fue de 0,89. La sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivo y negativo respecto al diagnóstico clínico fueron del 92,1, el 55,6, el 88,3 y el 65,9%, respectivamente, y respecto a la urodinámica, del 87,7, el 40,8, el 85,1 y el 46,2%, respectivamente.

CONCLUSIONES: Las propiedades psicométricas del ICIQ-SF han demostrado ser satisfactorias y permiten recomendar su uso en la práctica clínica para diagnosticar la IU.

Palabras clave: Incontinencia de orina. Mujer. Diagnóstico.

Validation of the Spanish version of the International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form. A questionnaire for assessing the urinary incontinence

BACKGROUND AND OBJECTIVE: A big proportion (40-70%) of patients with urinary incontinence (UI) do not ask for medical advice. Self-administered questionnaires may help in detecting UI. The objective of the present study was to validate the Spanish version of the questionnaire «ICIQ-SF».

PATIENTS AND METHOD: 500 women who consulted at a UI-specialized unit responded to the questionnaire. A urodynamic study was carried out and sociodemographic and clinical data were collected. Feasibility, validity and reliability were assessed. Sensitivity (Se), specificity (Sp) and positive (PPV) and negative (NPV) predictive values of the clinical and urodynamic study were also calculated.

RESULTS: The mean time of administration was 3.5 (1.5) minutes. All patients answered all the items of the ICIQ-SF. According to the clinical diagnosis, patients with UI scored 11.6 (5.9) and patients without UI scored 4.5 (6.3) ($p < 0.001$). According to the urodynamic diagnosis, UI patients scored 11.1 (6.3) vs 6.2 (6.5) ($p < 0.001$). In patients with an urodynamic diagnosis of «stress UI», a higher severity degree was associated with a higher score on the ICIQ-SF. The values of Se, Sp, PPV and NPV were 92.1%, 55.6%, 88.3% and 65.9%, respectively, regarding clinical diagnosis, and 87.7%, 40.8%, 85.1% and 46.2%, respectively, regarding the urodynamic study.

CONCLUSIONS: This is the first questionnaire designed for diagnosing UI validated in Spain. The psychometric properties of the ICIQ-SF are satisfactory and allow to recommend the use of the questionnaire in the clinical practice.

Key words: Urinary incontinence. Female. Diagnosis.

Este estudio se ha realizado con la ayuda de una beca de Eli Lilly España.

Correspondencia: Dra. M. Espuña Pons.
ICGON. Hospital Clínic de Barcelona.
Villarroel, 170. 08036 Barcelona. España.
Correo electrónico: mespuna@medicina.ub.es

Recibido el 3-9-2003; aceptado para su publicación el 20-11-2003.

La incontinencia urinaria (IU), según la International Continence Society (ICS), es la pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable que origina un problema social o higiénico¹. Su prevalencia media en mujeres en España, considerando cualquier tipo y gravedad, se estima en un 40,6%². De ellas sólo entre el 15 y el 40% buscan ayuda médica para este problema³⁻⁵. Cualquier estrategia que pretenda mejorar la atención a este problema de salud ha de plantear en primer lugar aumentar su detección. En este cometido, los profesionales de la salud tienen un papel fundamental, pero precisan de instrumentos útiles que no supongan una sobrecarga importante en el quehacer diario⁶.

Los cuestionarios autocumplimentados son instrumentos útiles para detectar la IU y para diseñar la estrategia de intervención en la población afectada por esta disfunción⁷. Según el comité de expertos de la Second International Consultation on Incontinence, existe una gran diversidad de cuestionarios, lo cual hace difícil la comparación de los resultados de los estudios, por lo que es necesario disponer de un instrumento que pueda utilizar el mayor número de investigadores. Este comité de expertos creó un nuevo cuestionario modular que incorpora todos los aspectos de la incontinencia: el International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ). Además desarrolló una versión muy corta de dicho cuestionario –ICIQ Short Form (ICIQ-SF)– con el objetivo de que pudiera utilizarse tanto en los estudios de investigación como en la práctica clínica⁸. El ICIQ-SF es un cuestionario que está orientado a la detección de la IU en cualquier ámbito asistencial. Su versión final, que se ha traducido y adaptado culturalmente en diversos países, consta de 3 ítems («frecuencia», «cantidad» y «afectación»), más un grupo de 8 preguntas relacionadas con el tipo de IU que no forman parte de la puntuación del cuestionario y tienen únicamente una finalidad descriptiva y orientadora sobre el tipo de IU. La puntuación total, resultado

de la suma de los 3 primeros ítems, va de 0 a 21 puntos. Estos 3 ítems han demostrado tener una elevada consistencia interna en la versión original del cuestionario (alfa de Cronbach = 0,917)⁹. El objetivo del presente estudio fue estudiar las propiedades psicométricas de la versión española del cuestionario de síntomas de IU, ICIQ-SF, para poder recomendar su uso en la práctica clínica habitual.

Pacientes y método

El cuestionario ICIQ-SF se ha adaptado culturalmente para España a partir de la versión original en inglés. El formulario se presenta en el anexo 1. Se ha seguido la técnica de doble traducción y retrotraducción, seguidas de una revisión del cuestionario resultante por un panel de expertos y no expertos. Finalmente se ha probado la equivalencia de las expresiones y la comprensión del cuestionario final.

Contestaron el cuestionario 500 mujeres que acudieron para la realización de un estudio urodinámico a la Unidad de Suelo Pélvico del Departamento de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, especializada en problemas de IU, entre noviembre de 2001 y junio de 2002. Además del citado estudio urodinámico y del cuestionario objeto de examen, se realizaron la historia clínica y la exploración física de todas las pacientes.

La sistemática del estudio fue la siguiente: al llegar la paciente a la unidad se le entregaba el cuestionario ICIQ para que lo rellenara en la sala de espera; una vez completado, se guardaba en un sobre. Antes de proceder al estudio urodinámico se realizaban la historia clínica y la exploración física. Se interrogaba a la paciente sobre la duración, el inicio y la presencia o ausencia de síntomas urinarios de urgencia, aumento de la frecuencia miccional, nicturia, escapes con los esfuerzos y escapes con sensación de urgencia. Finalmente se efectuaba el estudio urodinámico, que constaba de las siguientes pruebas: flujometría, cistometría de llenado, cisto/uroflujometría y perfil uretral en reposo. Estos datos se registraron a través de una hoja estandarizada de recogida de datos. El conjunto de variables permite disponer de 2 diagnósticos, uno clínico, basado en los síntomas, y otro urodinámico, para la evaluación del cuestionario objeto de examen. Se realizó el diagnóstico clínico de IU si la paciente contestaba de forma afirmativa al menos a una de las 2 preguntas siguientes: a) «¿Se le escapa la orina cuando hace un esfuerzo físico, como toser, estornudar, reír, levantar pesos, etc.?», y b) «¿Se le escapa la orina cuando nota una sensación urgente de ganas de orinar?». Se estableció el diagnóstico clínico de IU de esfuerzo cuando la paciente contestaba de forma afirmativa a la pregunta a y el diagnóstico clínico de IU de urgencia cuando contestaba de forma afirmativa a la pregunta b. La presencia o ausencia de otros síntomas urinarios, como la urgencia miccional, el aumento de frecuencia miccional y la nicturia, se investigó con las siguientes preguntas: c) «¿Siente a menudo la sensación repentina y urgente de ganas de orinar?», d) «¿Orina más de 7 veces al día?», y e) «¿Durante sus horas de sueño, ¿le despiertan más de una vez las ganas de orinar?». De acuerdo con el resultado del estudio urodinámico se clasificó a las pacientes en los siguientes grupos diagnósticos: a) incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando se evidenciara una pérdida de orina simultánea a la realización del esfuerzo de toser durante la cistometría, estando la paciente en bipedestación y con la vejiga a capacidad máxima, sin que se observara contracción del detrusor; b) hiperactividad del detrusor, si se evidenciaron contracciones del detrusor (de cualquier intensidad durante la cistometría de llenado o en las maniobras de provocación); c) IU mixta, si se observaron ambas situaciones en una misma paciente, y d) normalidad, cuando no se detectó ninguna anomalía en el estudio urodinámico. Se consideró que una paciente era incontinente desde el punto de vista urodinámico cuando pertenecía a cualquiera de los 3 primeros grupos diagnósticos.

Para las mujeres con evidencia de pérdida de orina con el esfuerzo durante el estudio urodinámico, es

decir, pacientes con diagnóstico urodinámico de IU de esfuerzo y de IU mixta, se empleó una sencilla clasificación de gravedad. Esta clasificación se basa en la observación del momento y la cantidad de la pérdida de orina con el esfuerzo de toser durante la cistometría y se realiza de la siguiente forma: al final de la cistometría de llenado, cuando la paciente ha expresado la sensación de haber llegado a su capacidad vesical máxima (máxima capacidad cistométrica), una vez retirada la sonda de llenado y con la sonda uretral de presión *in situ*, se solicita a la paciente que se ponga de pie y tosa con la máxima fuerza posible. Si se evidencia pérdida de orina con la tos en forma de chorro y al primer golpe de tos, se considera que tiene un grado 3 (máxima gravedad) de IU de esfuerzo; si se evidencia una pérdida en forma de chorro pero no al primer golpe de tos sino al segundo o tercero, se considera que tiene un grado 2 (intensidad moderada), y si se observa sólo un escape de unas gotas de orina al toser intensamente y de forma repetida, se considera que tiene un grado 1 (grado leve).

Con todos estos datos sobre el diagnóstico clínico y urodinámico de IU se realizó la evaluación de la factibilidad, validez y fiabilidad del cuestionario objeto de acuerdo con el procedimiento descrito más adelante. Además de evaluar las propiedades psicométricas del cuestionario ICIQ-SF, se trataba de evaluar su poder diagnóstico utilizando para ello como criterio de referencia el diagnóstico clínico basado en los síntomas, por un lado, y el diagnóstico urodinámico por otro.

El estudio de validación del cuestionario ICIQ-SF siguió las siguientes fases:

1. *Evaluación de su factibilidad.* Se realizó en función del tiempo medio de cumplimentación y de la respuesta a los ítems del cuestionario. Para evaluar la respuesta a los ítems se utilizó el porcentaje de pacientes que no respondieron a cada uno de ellos.

2. *Evaluación de su validez.* Se evaluó la validez de criterio comparando el diagnóstico proporcionado por el cuestionario con el clínico, basado en los síntomas de la paciente, y el urodinámico. Esto se hizo en 2 planos: a) análisis de la diferencia en la puntuación total del ICIQ-SF entre los pacientes que padecen y no padecen IU de acuerdo con los diagnósticos clínico y urodinámico, aplicando la prueba de la t de Student para muestras independientes, y b) grado de correlación entre el diagnóstico del tipo de IU aportado por los ítems marcados en el punto 6 del cuestionario y el del tipo según la clínica expresada por las pacientes y según el resultado de la prueba urodinámica, obtenido a través del establecimiento de tablas de contingencia mediante el coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente kappa y el porcentaje de acuerdo entre las clasificaciones.

La validez de constructo se evaluó en términos de validez discriminante mediante la comparación de la puntuación en el cuestionario objeto de examen entre los diferentes grados de gravedad de las pacientes con evidencia de IU de esfuerzo, de acuerdo con la clasificación antes explicada, aplicando el modelo ANOVA (test F de Fisher-Snedecor). Se realizó el análisis de la correlación existente entre la puntuación total del ICIQ y el grado de gravedad, a través del cálculo del coeficiente rho de Spearman. Se efectuó también la comparación de la puntuación en el cuestionario de las pacientes con diferentes tipos de IU de acuerdo con el estudio urodinámico (de esfuerzo, de urgencia o mixta) con el grupo de controles (sujetos sin IU) empleando para ello la prueba estadística de la t de Student para muestras independientes.

3. *Evaluación de su fiabilidad.* Se evaluó en términos de consistencia interna mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach.

4. *Evaluación del poder diagnóstico.* Se determinaron los valores predictivos positivo y negativo del cuestionario de síntomas de IU, así como su sensibilidad y especificidad, considerando como diagnóstico de IU de acuerdo con el cuestionario ICIQ-SF cualquier puntuación superior al cero. Para tener un buen test de cribado es muy importante que cuente con una alta especificidad y un alto valor predictivo negativo. En contraste, para un buen test diagnóstico se requieren sensibilidad y valor predictivo positivo elevados⁹.

Resultados

La edad media (desviación estándar) de las pacientes incluidas fue de 59,4 (13,2) años, y la paridad media fue de 2,4 (1,3) hijos. En 187 pacientes (37,4%) se estableció el diagnóstico urodinámico de IU de esfuerzo, en 92 (18,4%) el de IU de urgencia, en 80 (16%) de IU mixta, en 38 (7,6%) el de «otros» y en 103 (20,6%) el diagnóstico urodinámico fue de normalidad.

Evaluación de la factibilidad del cuestionario ICIQ-SF

El tiempo medio de administración del cuestionario fue de 3,5 (1,5) min. Ninguna paciente dejó algún ítem sin contestar.

Evaluación de la validez del cuestionario ICIQ-SF

De acuerdo con el diagnóstico clínico, las pacientes con IU obtuvieron una puntuación total media en el cuestionario ICIQ-SF de 11,6 (5,9), y las pacientes sin IU, de 4,5 (6,3) ($p < 0,001$). De acuerdo con el diagnóstico urodinámico, la puntuación media para las pacientes con IU fue de 11,1 (6,3), y para las pacientes sin IU, de 6,2 (6,5) ($p < 0,001$). Por otro lado, los resultados del estudio sobre el grado de correlación entre los ítems marcados en el punto 6 del cuestionario que pueden correlacionarse con el tipo de IU según la clínica expresada por las pacientes y según el diagnóstico urodinámico se presentan en la tabla 1. Respecto de la clínica expresada por las pacientes, el grado de correlación puede clasificarse de moderado (coeficientes entre 0,4 y 0,7) para los ítems 6.1, 6.2, 6.3 y 6.5. El grado de concordancia en la clasificación osciló entre el 84% de «ítem 6.1 frente a síntomas de IU» y el 70% de «ítem 6.5 frente a síntoma de IU de esfuerzo», manteniéndose

TABLA 1

Grado de correlación entre los ítems del grupo 6 del cuestionario y las clasificaciones clínica y urodinámica de incontinencia urinaria (IU)

Ítem	Variable	Diagnóstico clínico			Diagnóstico urodinámico			
		r	Kappa	Concordancia	r	Kappa	Concordancia	Variable
6.1	sin síntomas	0,48	0,48	84%	0,29	0,28	78,6%	Normalidad
6.2	IU de urgencia	0,62	0,60	80%	0,18	0,17	59,4%	Hiperactividad del detrusor
6.3	IU de esfuerzo	0,69	0,68	85,4%	0,43	0,42	72%	IU de esfuerzo
6.5	IU de esfuerzo	0,49	0,43	70,6%	0,33	0,32	65,6%	IU de esfuerzo

TABLA 2

Puntuaciones medias (desviación estándar) en el ICIQ para los diferentes grupos de gravedad de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) de acuerdo con el estudio urodinámico

Gravedad de la IUE	Puntuación total ICIQ, media (DE)
Baja (n = 90)	10,47 (5,61)
Intermedia (n = 98)	12,4 (5,72)
Alta (n = 70)	13,61 (5,42)

Modelo ANOVA (test F de Fisher-Snedecor); p = 0,002.

TABLA 3

Puntuaciones medias (desviación estándar) en el ICIQ para los diferentes grupos diagnósticos de incontinencia urinaria (IU) de acuerdo con el estudio urodinámico y los sujetos control sin IU

	Controles n = 103	IU de esfuerzo n = 187	p	IU de urgencia n = 92	p	IU mixta n = 80	p
Frecuencia	1,59 (1,83)	3,00 (1,60)	< 0,001	2,37 (1,90)	0,004	3,38 (1,40)	0,004
Cantidad	1,61 (1,70)	3,11 (1,59)	< 0,001	2,74 (2,15)	< 0,001	3,23 (1,54)	< 0,001
Afectación	2,95 (3,53)	5,50 (3,48)	< 0,001	4,64 (3,97)	0,002	6,28 (3,41)	0,002
ICIQ Total	6,17 (6,49)	11,60 (5,88)	< 0,001	9,61 (7,34)	0,001	12,85 (5,29)	0,001

Prueba de la t de Student, para muestras independientes de cada grupo respecto de los controles.

todos los casos por encima del 70%. El grado de correlación entre el diagnóstico del tipo de IU de acuerdo con los ítems marcados en el punto 6 del cuestionario y el del tipo de IU según el resultado de la prueba urodinámica fue menor que el de la clasificación clínica según la presencia o ausencia de síntomas (tabla 1). Para evaluar la validez de constructo se realizó el análisis de la correlación existente entre la puntuación total del ICIQ y el grado de gravedad definido durante el estudio urodinámico, para las pacientes con IU de esfuerzo y con IU mixta en las que se disponía de este dato (n = 258). El coeficiente de correlación rho de Spearman entre ambas variables fue de 0,23 (p < 0,01). De acuerdo con el grado de gravedad de la IU de esfuerzo, las pacientes se distribuyeron de la siguiente manera: a) baja, 90 pacientes (34,9%); b) intermedia, 98 pacientes (38%), y c) alta, 70 pacientes (27,1%). Los resultados de la prueba de comparación de medias entre los grupos definidos por la gravedad de la IUE de esfuerzo para la puntuación total del ICIQ se presentan en la tabla 2. Como puede verse, una mayor gravedad se asocia a una mayor puntuación total del ICIQ. Esto mismo se observó para los ítems «frecuencia», «cantidad» y «afectación» por separado; las diferencias entre grupos en todos los casos fueron estadísticamente significativas (p < 0,05).

En el último punto del estudio de la validez de constructo del cuestionario ICIQ-SF, se estudiaron las diferencias entre las pacientes con diferentes tipos de IU (de acuerdo con el estudio urodinámico) y los controles respecto de las puntuaciones total y de cada ítem («frecuencia», «cantidad» y «afectación»), resultados que se presentan en la tabla 3. La pun-

tuación total del ICIQ, así como la de los 3 ítems individualmente, sigue la tendencia hipotetizada, siendo en todos los casos superior en el grupo de pacientes con IU respecto a los controles.

Evaluación de la fiabilidad del cuestionario ICIQ-SF

Se calculó el alfa de Cronbach para los 3 ítems del cuestionario («frecuencia», «cantidad» y «afectación»), que fue de 0,89.

Evaluación del poder diagnóstico del cuestionario ICIQ-SF

De acuerdo con la clasificación clínica la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo obtenidos para el diagnóstico de IU de esfuerzo con el cuestionario objeto de examen fueron del 92,1, el 55,6, el 88,3 y el 65,9%, respectivamente. Con respecto a la clasificación urodinámica, los valores fueron, respectivamente, del 87,7, el 40,8, el 85,1 y el 46,2%.

Discusión

La falta de un instrumento simple y universalmente aceptado para el diagnóstico inicial de la IU es una de las causas por las que los estudios de prevalencia de este trastorno muestran una gran dispersión en sus cifras^{10,11}. Asimismo, el no disponer de un instrumento de esas características es una de las causas por las que al médico le resulta difícil incorporar el diagnóstico de esta disfunción en la práctica clínica diaria, lo cual contribuye a que la IU en la mujer siga siendo un problema infradiagnosticado. La detección de la IU se reduce, en la práctica, a preguntar a las pacientes si tienen escapes involuntarios de orina o algún tipo de

problema con la vejiga, y si le afecta en su vida diaria o le preocupa. Si la respuesta a las preguntas ha puesto en evidencia que existe un problema y que afecta a la calidad de vida de la mujer, el paso siguiente debe ser poner en marcha el proceso de diagnóstico para conocer el tipo de IU e indicar el tratamiento adecuado. Aunque existen cuestionarios de síntomas y calidad de vida para pacientes con IU, como el cuestionario King's Health, adecuadamente validado en nuestro país¹², su utilidad como instrumentos para la detección de la IU en la práctica clínica general está limitada por su extensión y el tiempo que requiere para su cumplimentación; en cambio son de gran utilidad en investigación.

Las propiedades psicométricas del cuestionario ICIQ-SF evaluadas en el presente estudio han demostrado ser satisfactorias y permiten recomendar su uso en la práctica clínica habitual para el diagnóstico inicial de la IU. Éste es el primer cuestionario corto de diagnóstico de la IU validado en España. Su brevedad y la sencillez de su puntuación e interpretación son características que lo hacen útil para la detección de la IU en cualquier ámbito asistencial, así como en estudios epidemiológicos.

La factibilidad del cuestionario ICIQ-SF de acuerdo con los resultados presentados es buena. El corto tiempo de administración lo convierte en una herramienta útil para su uso en la detección y diagnóstico inicial de la IU en una consulta médica.

Respecto a la validez de criterio, las pacientes con diagnóstico clínico y/o urodinámico de IU obtienen puntuaciones más altas en el ICIQ que las que no lo tienen, como se había hipotetizado. Los ítems del punto 6 del cuestionario mostraron en general un grado de correlación moderado con la clasificación clínica del tipo de IU; el grado de concordancia entre ambas clasificaciones fue superior al 70% en todos los casos. Cabe destacar que tanto el ítem 6.3 («pierde orina cuando tose o estornuda») como el 6.5 («pierde orina cuando hace esfuerzos físicos/ejercicio») pretenden valorar la presencia o ausencia de IU de esfuerzo; no obstante, el grado de concordancia y la correlación con la clínica son mejores para el ítem 6.3. Respecto a la clasificación urodinámica de la IU, estos ítems del punto 6 del cuestionario mostraron, en general, un grado de correlación bajo, lo que evidencia las grandes diferencias existentes entre lo que «percibe» la paciente y lo que realmente ocurre (demostrado por el estudio urodinámico). Se observa un moderado coeficiente de correlación (0,43) y una concordancia del 72% entre la respuesta positiva al ítem 6.3 y el diagnóstico urodinámico de

IU de esfuerzo. Esta observación coincide con la mayoría de los estudios que analizan el valor del diagnóstico clínico frente al urodinámico^{13,14}.

En el estudio de la validez de constructo, aunque el grado de correlación entre las 2 variables estudiadas en este apartado (grado de IU de esfuerzo y puntuación en el ICIQ) debe calificarse de bajo (rho de Spearman menor de 0,4), la puntuación total del ICIQ, así como la de los 3 ítems individualmente, sigue en general la tendencia hipotetizada (a mayor gravedad, mayor puntuación), y las diferencias entre grupos son estadísticamente significativas. Así, se confirma la hipótesis de que una mayor gravedad de la IU de esfuerzo se corresponde con mayor puntuación en el cuestionario objeto de examen. También la puntuación total del ICIQ y la de los 3 ítems individualmente («frecuencia», «cantidad» y «afectación») de cada grupo diagnóstico, de acuerdo con el estudio urodinámico respecto del grupo control, siguen la tendencia hipotetizada, y en todos los casos es superior en el grupo de pacientes con IU respecto a los controles.

La consistencia interna del cuestionario medida por el alfa de Cronbach resultó ser elevada, muy cercana al 0,92 obtenido en la versión original en inglés.

Aunque la sensibilidad al cambio se evaluará en profundidad en un estudio prospectivo en marcha, esta elevada fiabilidad indica que probablemente el instrumento ICIQ-SF es útil en el seguimiento de pa-

cientes antes y después de la aplicación de tratamientos para la IU.

Los valores elevados de sensibilidad y el valor predictivo positivo son indicadores de la calidad del cuestionario como instrumento diagnóstico de IU. El hecho de que la puntuación obtenida con la respuesta a tan sólo 3 ítems detecte el 92,1% de los casos con IU de acuerdo con el diagnóstico clínico, o el 87,7% de los casos de acuerdo con el diagnóstico urodinámico, lo convierte en un cuestionario extremadamente útil para su uso en la detección de la IU oculta, que supone entre el 40 y el 70% del total.

Agradecimientos

Los autores agradecen la entusiasta colaboración de Amelia Pérez González y Amparo Solsona por su inestimable ayuda en el mantenimiento de los datos del estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. Standardisation Subcommittee of the International Continence Society. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Subcommittee of the International Continence Society. *Neurourol Urodyn* 2002;21:167-78.
2. Rebollo P, Espuña M. Situación actual del diagnóstico y tratamiento de la incontinencia de orina en España. *Arch Esp Urol* 2003;56:755-74.

3. Sánchez R, Rupérez O, Delgado MA, Mateo R, Hernando MA. Prevalencia de incontinencia urinaria en la población mayor de 60 años atendida en atención primaria. *Aten Primaria* 1999;24:421-4.
4. Bretones JJ, Pino M, García MA, Fajardo ML, Sáez JM, Ortega I. Incontinencia urinaria en mujeres en edad adulta: estudio descriptivo en una población rural. *Aten Primaria* 1997;20:45-8.
5. Damián J, Martín-Moreno JM, Lobo F, Bonache J, Cervino J, Redondo-Márquez L, et al. Prevalence of urinary incontinence among Spanish older people living at home. *Eur Urol* 1998;34:333-8.
6. Espuña M. Incontinencia de orina en la mujer. *Med Clin (Barc)* 2003;120:464-72.
7. Abrams P, Khoury S, Wein A. Incontinence. 1st International Consultation on Incontinence (WHO, ICS) Monaco 1998. Plymouth: Plymbridge Distributors Ltd., 1999.
8. Donavan JL. Symptom and quality of life assessment. En: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A. Incontinence. Second International Consultation on Incontinence. Plymouth: Plymbridge Distributors Ltd, 2002.
9. Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall, 1991; p. 409-19.
10. Hunskaar S, Arnold EP, Burgio K, Diokno AC, Herzog AR, Mallett VT. Epidemiology and natural history of urinary incontinence. *Int Urogynecol J* 2000;11:301-19.
11. Hampel C, Wienhold D, Benken N, Eggersmann C, Thuroff JW. Prevalence and natural history of female incontinence. *Eur Urol* 1997;32(Suppl 2):3-12.
12. Badía X, Castro D, Conejero J. Validez del cuestionario King's Health para la evaluación de la calidad de vida en pacientes con incontinencia urinaria. *Med Clin (Barc)* 2000;114:647-52.
13. Jenssen JK, Nielsen F, Ostegard D. The role of patient history in the diagnosis of urinary incontinence. *Obstet Gynecol* 1994;83:904-10.
14. Harvey MA, Versi E. Predictive value of clinical evaluation of stress urinary incontinence: a summary of the published literature. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2001;12:31-7.

ANEXO 1

	ICIQ-SF (versión española)	
Número inicial	CONFIDENCIAL	Fecha de hoy Día Mes Año
Hay mucha gente que en un momento determinado pierde orina. Estamos intentando determinar el número de personas que presentan este problema y hasta qué punto les preocupa esta situación. Le estaríamos muy agradecidos si nos contestase las siguientes preguntas, pensando en cómo se ha encontrado en las <i>últimas cuatro semanas</i> .		
1. Por favor, escriba la fecha de su nacimiento:		
DÍA MES AÑO 		
2. Usted es (señale cuál):		
Mujer ☐ Varón ☐		
3. ¿Con qué frecuencia pierde orina? (marque una):		
Nunca ☐ 0		
Una vez a la semana o menos ☐ 1		
Dos o tres veces a la semana ☐ 2		
Una vez al día ☐ 3		
Varias veces al día ☐ 4		
Continuamente ☐ 5		

ANEXO 1 (Continuación)

4. Nos gustaría saber su impresión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa. Cantidad de orina que pierde <i>habitualmente</i> (tanto si lleva protección como si no) (<i>marque uno</i>):																							
	No se me escapa nada ☐ 0 Muy poca cantidad ☐ 2 Una cantidad moderada ☐ 4 Mucha cantidad ☐ 6																						
5. Estos escapes de orina que tiene, ¿cuánto afectan su vida diaria? (por favor, marque un círculo en un número entre 0 –no me afectan nada– y 10 –me afectan mucho–: <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>Nada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Mucho</td> </tr> </table> Puntuación de ICI-Q: sume las puntuaciones de las preguntas. 3 + 4 + 5 =		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nada										Mucho
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
Nada										Mucho													
6. ¿Cuándo pierde orina? (<i>señale todo lo que le pasa a usted</i>): <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">6.1</td> <td style="text-align: right;">Nunca pierde orina ☐</td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td style="text-align: right;">Pierde orina antes de llegar al WC ☐</td> </tr> <tr> <td>6.3</td> <td style="text-align: right;">Pierde orina cuando tose o estornuda ☐</td> </tr> <tr> <td>6.4</td> <td style="text-align: right;">Pierde cuando duerme ☐</td> </tr> <tr> <td>6.5</td> <td style="text-align: right;">Pierde orina cuando hace esfuerzos físicos/ejercicio ☐</td> </tr> <tr> <td>6.6</td> <td style="text-align: right;">Pierde orina al acabar de orinar y ya se ha vestido ☐</td> </tr> <tr> <td>6.7</td> <td style="text-align: right;">Pierde orina sin un motivo evidente ☐</td> </tr> <tr> <td>6.8</td> <td style="text-align: right;">Pierde orina de forma continua ☐</td> </tr> </table>		6.1	Nunca pierde orina ☐	6.2	Pierde orina antes de llegar al WC ☐	6.3	Pierde orina cuando tose o estornuda ☐	6.4	Pierde cuando duerme ☐	6.5	Pierde orina cuando hace esfuerzos físicos/ejercicio ☐	6.6	Pierde orina al acabar de orinar y ya se ha vestido ☐	6.7	Pierde orina sin un motivo evidente ☐	6.8	Pierde orina de forma continua ☐						
6.1	Nunca pierde orina ☐																						
6.2	Pierde orina antes de llegar al WC ☐																						
6.3	Pierde orina cuando tose o estornuda ☐																						
6.4	Pierde cuando duerme ☐																						
6.5	Pierde orina cuando hace esfuerzos físicos/ejercicio ☐																						
6.6	Pierde orina al acabar de orinar y ya se ha vestido ☐																						
6.7	Pierde orina sin un motivo evidente ☐																						
6.8	Pierde orina de forma continua ☐																						
Muchas gracias por contestar estas preguntas. ☐ ☐																							